Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Autos n° 0823328-73.2024.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Gustavo Faria de Oliveira
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

SENTENÇA
I - RELATÓRIO

GUSTAVO FARIA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, propôs **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** em face de **UNIMED - CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, também com qualificação nos autos, formulando os seguintes pedidos:

> ***"d) Requer seja confirmada a tutela antecipada concedida, bem como seja a ação julgada PROCEDENTE em todos os seus termos, declarando a nulidade da cláusula contratual que afasta a cobertura de tratamento médico, bem como condenando a Ré à arcar com o custeio integral de todo o tratamento de saúde, necessários à sua recuperação, notadamente quanto com ao custeio da medicação indicada de TEMODAL MANUTENÇÃO associado a BEVACIZUMABE, nos termos da descrição do RELATÓRIO MÉDICO, bem como todos os exames, materiais, medicamentos e procedimentos acessórios ou incidentais do tratamento até a sua integral recuperação.***
>
> ***e) Requer ainda seja a Ré condenada ao pagamento de indenização em***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

razão dos danos morais suportados pelo Autor, em valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou valor a ser fixado por este MM. Juízo, bem como que haja a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no art. 85, do CPC;

Como causa de pedir, sustenta que é beneficiário do plano de saúde da parte requerida.

Esclareceu que, foi diagnosticado como portador de câncer no cérebro (neoplasia maligna de SNC, CID C71), estando em tratamento desde setembro de 2023, ainda sem alta médica.

Relatou que seu médico optou seguir o tratamento com o uso do medicamento denominado TEMODAL MANUTENÇÃO associado a BEVACIZUMABE (AVASTIN/ELOVIE), visto que tal medicação é indicada especificamente para câncer dessa natureza.

Afirmou que solicitou à parte requerida a autorização para a realização do tratamento nos termos solicitados pelo médico, no entanto, a requerida não autorizou a medicação, sob o argumento de que não haveria comprovação de que referido medicamento traria sobrevida ao paciente, tratando-se de medicamento excluído da cobertura em razão de seu caráter experimental.

Observou que o medicamento em questão é de alto custo.

Por tais motivos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, aduzindo presentes os requisitos legais necessários ao seu deferimento, para a finalidade de determinar que a parte requerida autorize o tratamento nos termos solicitados pelo seu médico, como todos os exames, materiais, medicamentos e procedimentos acessórios ou incidentais do tratamento.

Na decisão de fls. 78/86 foi deferida a tutela de urgência para o fim fim de determinar que a parte requerida autorize o início do tratamento e dos medicamentos, aqui englobando-se todos os exames necessários, nos exatos termos

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

solicitados pelo médico da parte autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de responder por multa diária.

A parte ré foi citada (fl. 98), sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 174/198), alegando, em síntese o seguinte: 1) defeito na representação processual; 2) impossibilidade de cobertura do medicamento; 3) ausência de previsão contratual; 4) no caso dos autos, necessário elucidar que houve autorização por parte da UNIMED CAMPO GRANDE do medicamento TEMOZOLAMIDA, entretanto houve negativa no que se refere ao BEVACIZUMABE, de nome comercial AVASTIN, por se tratar de fármaco *off label*, cuja indicação médica diverge do que consta em sua bula; 5) referido medicamento é considerado tratamento experimental; 5) não houve falha na prestação do serviço, pois a ré está respaldada pelas disposições contratuais firmadas entre as partes; e 6) inocorrência de danos morais.

A parte autora impugnou os termos da contestação na manifestação de fls. 279/283.

Foi designada audiência de conciliação, a qual restou sem êxito (fl. 172).

As partes foram instadas a especificar as provas que pretendem produzir e postularam o seguinte: 1) a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 288/289); 2) a parte ré protestou pela produção de prova pericial e oitiva da parte autora (fls. 290/291).

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.I – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Em que pese a parte requerida pugnar pela produção de prova oral e pericial, com a finalidade de comprovar a efetividade do tratamento requerido à parte autora, tais requerimentos devem ser indeferidos.

Com efeito, a prova oral e a prova perícia para provar a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

alegação de que o tratamento requerido pelo autor não era indicado à sua patologia são desnecessárias, uma vez que o pedido está amparado em prescrição de profissional que o acompanha.

Ademais, o pleito nos termos em que está formulado pela requerida, aparentemente, busca firmar uma premissa de julgamento para o feito, o que é processualmente inadequado, posto que constituiria tentativa de obter um "parecer" para substituir a prescrição do médico que realiza o tratamento da autora.

Ressalta-se que, na atividade de julgar, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, ***"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento"***, de modo que a análise de eventual obrigação de fazer deve ser realizada levando-se em consideração as resoluções atinentes ao caso e ao Código Civil.

Na espécie, incide o disposto no at. 355, I, do Código de Processo Civil, no qual assevera que "***O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas".***

Logo, **INDEFIRO** a produção de prova pericial e oral requeridas pelas partes e passo analisar a julgar antecipadamente a presente ação.

II.II - PRELIMINAR

II.II.I – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

A parte autora regularizou sua representação processual com a juntada de Instrumento de Procuração devidamente assinado e juntado à fl. 284.

Diante do exposto, **INDEFIRO A PRELIMINAR** sustentada na contestação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

II.III - MÉRITO

II.III.I – OBRIGAÇÃO DE FAZER

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual a parte autora busca a condenação da requerida em proceder a assistência médica para a realização do tratamento com medicamento Bevacizumabe (AVASTIN®), bem como a condenação no pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, a teor do que disciplina do artigo 3º, § 2º, do CDC, corroborado pelo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 608, ***"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".***

Em semelhantes litígios deve ocorrer a facilitação da defesa do consumidor em juízo e pode até ser determinada a inversão do ônus da prova, tudo nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, e com base na legislação consumerista, deve-se repelir do contrato firmado entre as partes toda e qualquer cláusula que implique em contrariedade à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Com isso, é possível afirmar que os direitos básicos do consumidor e as suas normas protetivas devem todas ser aplicadas no contrato em questão, principalmente o art. 6º, V, que estabelece a possibilidade da quebra da base objetiva do contrato, excetuando, portanto, o princípio do *pacta sun servanda.*

Além disso, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de cumprirem as obrigações legais e contratuais.

Os artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, dispõem:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé";

"Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente";

"Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio".

O art. 422 acima mencionado, consagra o princípio da boa-fé objetiva, consoante o qual as partes devem se comportar com probidade e boa-fé desde a formação do contrato e também durante toda a sua execução.

Nas lições de CARLOS ROBERTO GONÇALVES, por decorrência de tal princípio, o juiz ***"Deve este, ao julgar demanda na qual se discute a relação contratual, dar por pressuposta a boa-fé objetiva, que impõe a um contratante um padrão de conduta, de agir com retidão, ou seja, com probidade, honestidade e lealdade, no moldes do homem comum, atendidas as peculiaridades dos usos e costumes do lugar"([1])***.

A respeito do alcance de tal princípio, o E. STJ e E. TJ/MS decidiram o seguinte:

"(...) Todo contrato desempenha uma função social, deve ser interpretado conforme a boa-fé e também deve guardar desde a conclusão e durante a sua execução esse mesmo princípio, assim como o da probidade (arts. 113 e 422 do CC/02).(...)." ([2]).

"(...) Viola a boa-fé objetiva dos contratos adotar conduta divergente do pactuado e esperado pelo contratante, de modo que o comportamento contraditório e desleal, implica em exercício abusivo de direito ferindo o interesse social das relações jurídicas. (...)" ([3]).

---

[1] DIREITO CIVIL BRASILEIRO, ed. Saraiva, 2008, volume III, p.33.

[2] **STJ**; REsp 1363814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 30/10/2017.

[3] **TJMS**. Apelação n. 0809609-05.2016.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 29/01/2019, p: 31/01/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

Ademais, observa-se que, na existência de cláusulas ambíguas ou contraditórias em contratos de adesão, o contratante é beneficiado com a interpretação mais favorável, bem como que eventual limitação contratual deve ser considerada nula.

Nesse diapasão, a Lei nº 9.656/1998, que trata dos Planos Privados de Saúde, é expressa em estabelecer, no artigo 10, o plano de referência de assistência à saúde, com as coberturas médico ambulatorial e hospitalar, trazendo as coberturas mínimas de qualquer plano, ou seja, os itens que todo plano de saúde deve cobrir, tais sejam:

> ***"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:***
>
> ***I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;***
>
> ***II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;***
>
> ***III - inseminação artificial;***
>
> ***IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;***
>
> ***V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;***
>
> ***VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;***
>
> ***VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;***
>
> ***IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;***
>
> ***X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente".***

Da mesma forma, também tem como exigência mínima de tais contratos, a previsão de cobertura de *"cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente"*,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

conforme se observa do art. 12, I, "b", da referida Lei:

> ***"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:***
> ***I - quando incluir atendimento ambulatorial:***
> ***(...)***
> ***b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (...)".***

Logo, constata-se que, via de regra, o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico da autora, deve ser coberto pelo plano de saúde.

Nesse ponto aliás, a jurisprudência do E. STJ ***"reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas."*** (AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

No mesmo diapasão, certamente diante da quantidade de demandas sobre a matéria, o E. TJ/SP editou as súmulas 96 e 102, que assim dispõem:

> ***"Súmula 96 - Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento".***
>
> ***"Súmula: 102 - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS".***

Também a jurisprudência do E. TJ/MS trilha no mesmo caminho, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais foram colhidos entre muitos de igual teor:

> ***"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA EM***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

PRIMEIRO GRAU – LIMITAÇÃO DE COBERTURA RELATIVA A TRATAMENTO RPG – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – CLAUSULA ABUSIVA – RELAÇÃO CONTRATUAL – COBERTURA DE FISIOTERAPIA – NÃO CABE AO PLANO DECIDIR QUAL MÉTODO E SIM AO MÉDICO – TUTELA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não cabe ao plano decidir qual tratamento deve ou não ser utilizado para recuperação da saúde de um paciente. 2. Uma vez disponibilizada a cobertura ela não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas serão utilizadas no tratamento da doença para a qual o contrato preveja cobertura" ([4]).

"E M E N T A – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÍNDROME MIELODISPLÁSTICAS DO SUBTIPO ANEMIA REFRATÁRIA – DIREITO DO PACIENTE A RECEBER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE O ACOMPANHA – URGÊNCIA DA MEDIDA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA PATOLOGIA QUE PROGRIDE COM POSSIBILIDADE DE ÓBITO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DE SER PROFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, VIII, DO CPC/2015 C/C 138, IV, DO RITJMS – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Diante da autorização de se proferir decisões monocráticas, concedida pela junção dos artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 com o art. 138, IV, do RITJMS, não há que se falar em nulidade. Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum que negou provimento de plano ao recurso ante a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios" ([5]).

No presente caso, através dos documentos juntados às 28/31, restou incontroverso que o autor beneficiário de plano de saúde junto à requerida.

Além disso, a necessidade do tratamento requerido pelo autor resta demonstrado pelos documentos/laudos de fls. 32/33, onde consta indicação prescrita pelos médicos ERLON KLEIN (CRM/MS 4002) e MARIA JULIA ÁVILA (CRM 12544), ambos especialista na área de oncologia, nos seguintes termos:

"Trata-se, portanto, de paciente jovem, com glioblastoma,

[4] **TJMS**; Agravo de Instrumento - Nº 1406439-42.2017.8.12.0000 - Dourados Relator : Exmo. Sr. Des. Amaury da Silva Kuklinski, julgado em 25/07/2018.
[5] **TJMS**; Agravo Interno - Nº 2000334-79.2018.8.12.0900/50000 - Bela Vista - Relator – Exmo. Sr. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, julgado em 25/07/2018.

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

bastante sintomático da doença. Diante da rápida progressão mesmo após radioterapia concomitante a temodal, além de componente importante de edema e risco de radionecrose, necessita de temodal manutenção associado a bevacizumabe, com urgência. Sabe-se que não temos outra opção de segunda linha nesse cenário". (fl. 33)

Ademais, através dos documentos de fls. 71/72, o autor comprova que a parte requerida não autorizou o tratamento indicado, ou seja, refugou o tratamento indicado pelos médicos que acompanham o autor.

A requerida, por sua vez, sustenta que a realização do tratamento com o uso do citado medicamento não está contemplada com cobertura pelas Diretrizes de Utilização - DUT, bem como que não está previsto no rol de coberturas mínimas exigidas pela ANS, tratando-se de tratamento de "caráter experimental".

Em que pese a manifestação da requerida e a negativa de fls. 70/722, tal tese não merece prosperar.

É cediço que, o contrato firmado pelas partes é de trato contínuo visando à prestação de serviços de assistência à saúde, de modo que, havendo previsão de cobertura para a doença que o paciente pode apresentar, como no presente caso, é justa a sua expectativa de cobertura para a busca do tratamento médico que lhe for recomendado.

Ressalta-se que a finalidade do contrato em questão, assim como a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, permite o reconhecimento de que a recusa pela requerida foi injusta.

No que se refere ao pedido de fornecimento do medicamento objeto dos autos - Bevacizumabe (AVASTIN®), a matéria posta a decisão já foi objeto de decisão em outros feitos, nos quais se reconheceu o dever do plano de saúde fornecer tal medicamento, mesmo que não conste do rol de procedimentos da ANS, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais referem-se especialmente sobre os medicamentos indicados ao autor:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. CID10 C18. NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. BEVACIZUMABE/AVASTIN. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso provido discute-se no presente recurso a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada. O direito à saúde é garantido constitucionalmente o que evidencia a probabilidade do direito. No caso, restou demonstrada a probabilidade do direito da autora, cuja necessidade de tratamento foi atestada pelo médico e evidenciada pelas circunstâncias de seu quadro de saúde, restando justificada a concessão do medicamento". ([6])

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu pedido liminar de cobertura de tratamento à paciente acometida de adenocarcinoma de cólon, com metástase cerebral com o medicamento Bevacizumabe (AVASTIN®), sob pena de multa diária. Insurgência da operadora de plano de saúde em virtude da utilização off label do fármaco. Argumento cuja análise em sede de agravo de instrumento se mostra inviável ante a necessidade de dilação probatória e formação de pleno contraditório. Exame, para o momento, do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, cuja incidência ao caso em tela se mostra adequada. Precedentes. Valor da multa estipulada que se mostra suficiente à finalidade a que se destina. Decisão mantida. RECURSO IMPRÓVIDO".([7])

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Tutela Provisória de Urgência. Beneficiário diagnosticado com Hepatocarcinoma. Recusa do fornecimento do medicamento Atezolizumabe associado a Bevacizumabe. Abusividade. Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento. Prescrição médica. Obrigatoriedade da cobertura do medicamento para tratamento de câncer, ainda que para uso off label. Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas nºs 95 e 102 do TJSP. Não se pode opor a vigente Resolução Normativa RN n. 465/2021 da ANS naquilo em que viola a Lei n. 8.078/90 (Súmula nº 608 STJ) quanto à devida prestação dos serviços contratados, a não ser que a Operadora demonstre que existe, para a cura ou atendimento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, consoante entendimento dos ERESP 1886929 e ERESP 1889704. Cobertura obrigatória de medicamento para tratamento

[6] **TJMS**; AI 1409620-41.2023.8.12.0000; Dourados; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 26/09/2023; Pág. 118

[7] **TJSP;** AI 2021944-87.2024.8.26.0000; Ac. 17747194; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pastorelo Kfouri; Julg. 03/04/2024; DJESP 08/04/2024; Pág. 1972)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

de câncer. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Recurso desprovido". ([8])

Aliás, o medicamento aqui buscado está devidamente registrado na ANVISA (Registro ANVISA nº 101000637 – AVASTIN).

Dessa forma, a parte requerida não poderia negar o fornecimento do tratamento pretendido, indicado por médico responsável pelo acompanhamento da saúde da parte autora (fl. 33).

Ademais, são indiscutíveis os benefícios da realização de tal tratamento para estancar a evolução da doença, logo, não se visualiza qualquer justificativa plausível a negativa no fornecimento do referido medicamento.

No que tange a alegação de que o medicamento requerido não está previsto no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, a mesma não merece prosperar, uma vez que a listagem feita pela agência reguladora não é taxativa.

Isto porque, cuida-se de uma relação mínima, de uma lista de consultas, exames e tratamentos que os planos de saúde contratados a partir de 02 de janeiro de 1999 são obrigados a fornecer.

O rol da ANS é meramente exemplificativo e, havendo expressa indicação médica, como ocorreu na espécie, é abusiva a negativa de cobertura de custeio do tratamento médico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou em caso semelhante:

> ***"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de***

[8] TJSP; AI 2017396-19.2024.8.26.0000; Ac. 17594654; Sorocaba; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 20/02/2024; DJESP 26/02/2024; Pág. 1638

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. 3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ. 5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental não provido" ([9]).

Portanto, comprovada a necessidade de realização do tratamento com o uso do medicamento denominado Bevacizumabe (AVASTIN®), e não havendo nos autos qualquer motivo para infirmar a veracidade do que foi atestado pelo médico do paciente, o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, ratificando-se os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência à parte autora.

II.III.II – DANOS MORAIS

Para que exista o dever de indenizar, como é sabido, é necessário que estejam presentes os elementos da responsabilidade civil, tais sejam: ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo.

Nesse sentido são as disposições dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil vigente, que, assim dispõem:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou

[9] **STJ** - AgRg no REsp 1546908 / RS, Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 03/05/2016.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Logo, provada existência da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que cause prejuízo a outrem, o responsável pela violação fica obrigado a reparar o dano causado.

No que pertine à caracterização do dano moral, são pertinentes as lições sempre atuais de Yussef Said Cahali "***Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral***;" ([10]).

Com efeito, as provas produzidas evidenciaram a necessidade do medicamento solicitado pelo médico da parte autora, mas houve falha na prestação de serviço, na contramão da função social do contrato e do âmago da sua essência.

A propósito, importante destacar o julgado do Tribunal de Justiça deste Estado, a seguir transcrito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR RECHAÇADA – TRANSPLANTE DE RIM – DIREITO AO REEMBOLSO DO TOTAL DAS DESPESAS – DANOS MORAIS DEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, RECURSO CONHECIDOS, RECURSO DO PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). No caso específico, não há como negar a cobertura do total das despesas com o procedimento (transplante de rim), uma vez que definidos os valores de reembolso mediante critérios inespecíficos cujas informações não foram devidamente repassadas ao consumidor. (...) Na hipótese, restaram configurados os

[10] Dano Moral, ed. RT., 2000, p. 20.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

pressupostos necessários à configuração dos danos de ordem moral, porquanto a injusta recusa de cobertura de plano de saúde aumentou o sofrimento do segurado, que inegavelmente ficou abalado emocionalmente diante da recusa de cobertura para que realizasse a cirurgia que necessitava transplante de rim - procedimento essencial para o restabelecimento de sua saúde (...)" ([11]).

Ressalta-se que tal recusa indevida da cobertura do plano de saúde, ocorreu em um momento delicado na vida da parte autora, que se trata de pessoa diagnosticada com câncer no cérebro ("NEOPLASIA MALIGNA DE SNC, CID C71").

Logo, a negativa à realização do tratamento indicado para a parte autora causou manifesto sofrimento desnecessário, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser procedente.

Nesse contexto resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora, razão pela qual fixo o valor da indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente adequado à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, considerando ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas.

Deve ser considerado que a parte requerida é uma empresa de serviços médicos de grande porte, com grande número de clientes, que tem condições de prevenir a ocorrência de semelhantes ilícitos com tecnologia e mão de obra especializada, mesmo assim acabou por violar o direito da parte autora.

O valor fixado deverá ser atualizado pela variação do IPCA-E, desde a data desta sentença, com fim de preservar-se ante a espiral inflacionária.

Observo que a atualização monetária não constitui um *plus* no débito, mas mera recomposição de valores ante à espiral inflacionária, sendo adequada a utilização do IPCA-E, posto que se trata de índice que reflete a efetiva variação do custo de vida.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, nos

[11] **TJMS.** Apelação n. 0800769-47.2015.8.12.0031, Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 12/12/2017, p: 18/12/2017.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

termos da jurisprudência do STJ (Recurso Especial nº 903258/RS), o termo inicial dos juros de mora em reparação por danos morais deve ser a partir da fixação do valor da indenização.

O percentual dos juros moratórios deve corresponder a 1% (um por cento) ao mês, visto que se aplica ao caso disposto no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional (Enunciado 20 do CEJ).

III - DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo nos arts. 422, 423 e 424, 186 e 927, todos do Código Civil, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** formulados na petição inicial para o fim de:

1) condenar a requerida em fornecer o medicamento Bevacizumabe (AVASTIN®) à parte autora, na forma e tempo prescritos pelo médico que lhe assiste;

Por reputar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, **CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA** deferida nos autos às fls. 58/67;

2) condenar a parte requerida no pagamento de indenização por dano moral à parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pela variação do IPCA-E desde a data desta sentença, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também desde a data desta sentença.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais, à vista do grau de zelo do profissional, o local de prestação de serviço (atendimento na Comarca), a natureza e a importância da causa (pouca complexidade) e os atos processuais praticados (feito não instruído), bem como considerando a diversidade de pedidos deferidos –

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.

obrigação de fazer e indenização por dano moral -, arbitro equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil).

Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Campo Grande/MS, *data do sistema*.

Wilson Leite Corrêa
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 27/02/2025 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0823328-73.2024.8.12.0001 e código VscqRdob.